

Gestión de reconstrucciones y escaneo en tomógrafo Canon

Este video detalla la administración de reconstrucciones y transferencias de imágenes en un tomógrafo computado Canon Aquilion. El instructor describe cómo supervisar el envío de series, verificar la temperatura del tubo y cargar la información del paciente desde el servidor o manualmente para proceder al escaneo.

VIDEO	TC_06_Envio_series_calentamiento_tubo_worklist
FECHA	25/09/2026
DURACIÓN	04:39 (mm:ss)
PASOS	9
SECCIONES	3

Índice

Gestión de datos

1. No detener la transferencia accidentalmente	00:03 ·	pág. 3
2. Verificar el estado de las transferencias	00:25 ·	pág. 3
3. Reiniciar un envío de imágenes	00:36 ·	pág. 4
4. Evitar detener la reconstrucción de imágenes	01:03 ·	pág. 4

Seguridad y sistema

5. Monitorear la temperatura del tubo	01:41 ·	pág. 5
6. Advertencia de enfriamiento automático	02:13 ·	pág. 5

Planificación del estudio

7. Iniciar registro rápido de emergencia	03:45 ·	pág. 6
8. Seleccionar protocolo por anatomía	03:52 ·	pág. 6
9. Cargar paciente desde el servidor	04:10 ·	pág. 7



PASO 1 · GESTIÓN DE DATOS · 00:03

No detener la transferencia accidentalmente

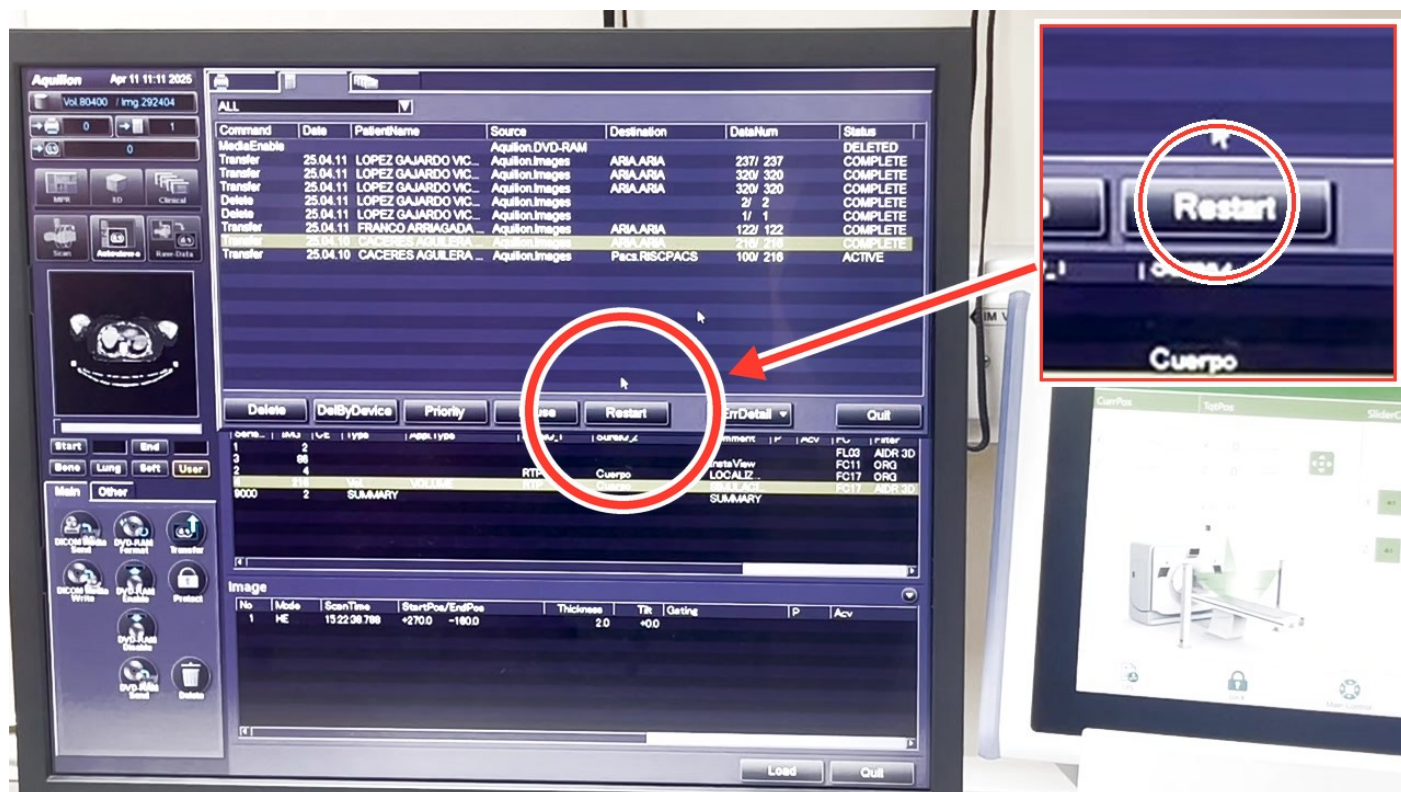
El instructor aconseja no hacer clic en el boton del contador de transferencias activas (marcado con 2 en pantalla), a menos que haya un problema, ya que de lo contrario se detendra el proceso y se pondra en espera (Hold).



PASO 2 · GESTIÓN DE DATOS · 00:25

Verificar el estado de las transferencias

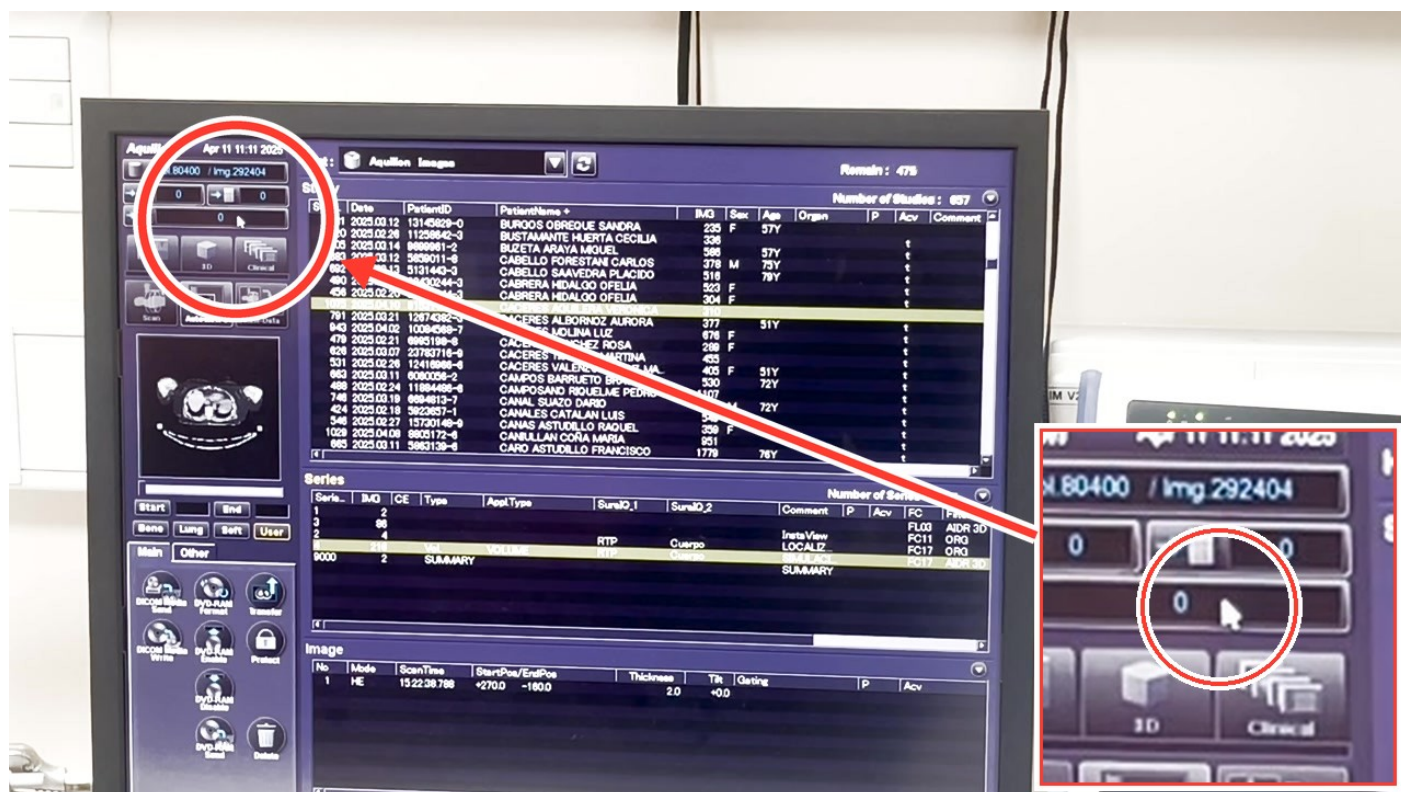
Hacer clic en el boton de transferencia (icono de tres pantallas conectadas) en el menu de utilidades de la izquierda para visualizar el listado de envios, confirmando si estan COMPLETE o ACTIVE.



PASO 3 · GESTIÓN DE DATOS · 00:36

Reiniciar un envío de imágenes

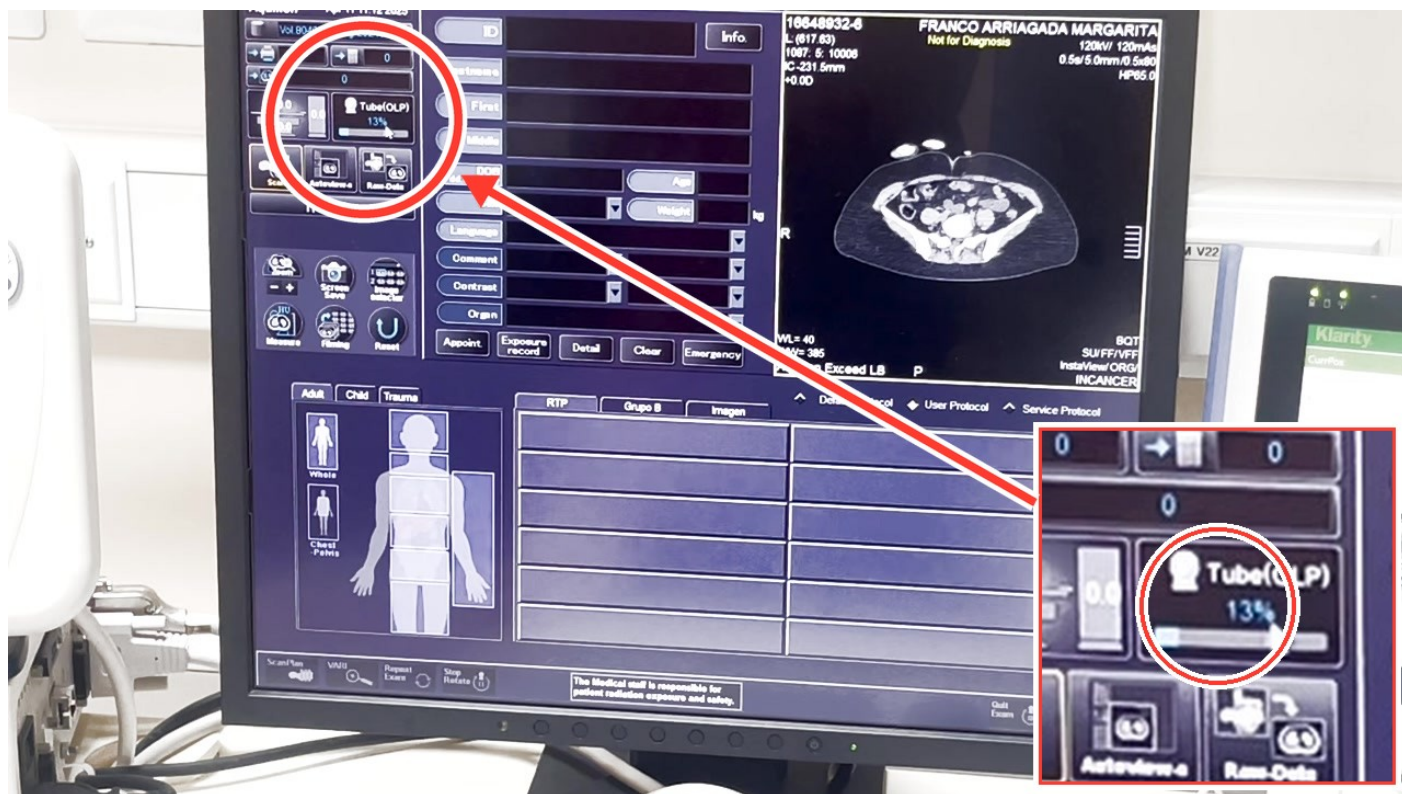
Si un envío se interrumpe, se puede seleccionar la fila correspondiente en la lista de comandos y hacer clic en el botón 'Restart' para reiniciar el envío al PACS o destino deseado.



PASO 4 · GESTIÓN DE DATOS · 01:03

Evitar detener la reconstrucción de imágenes

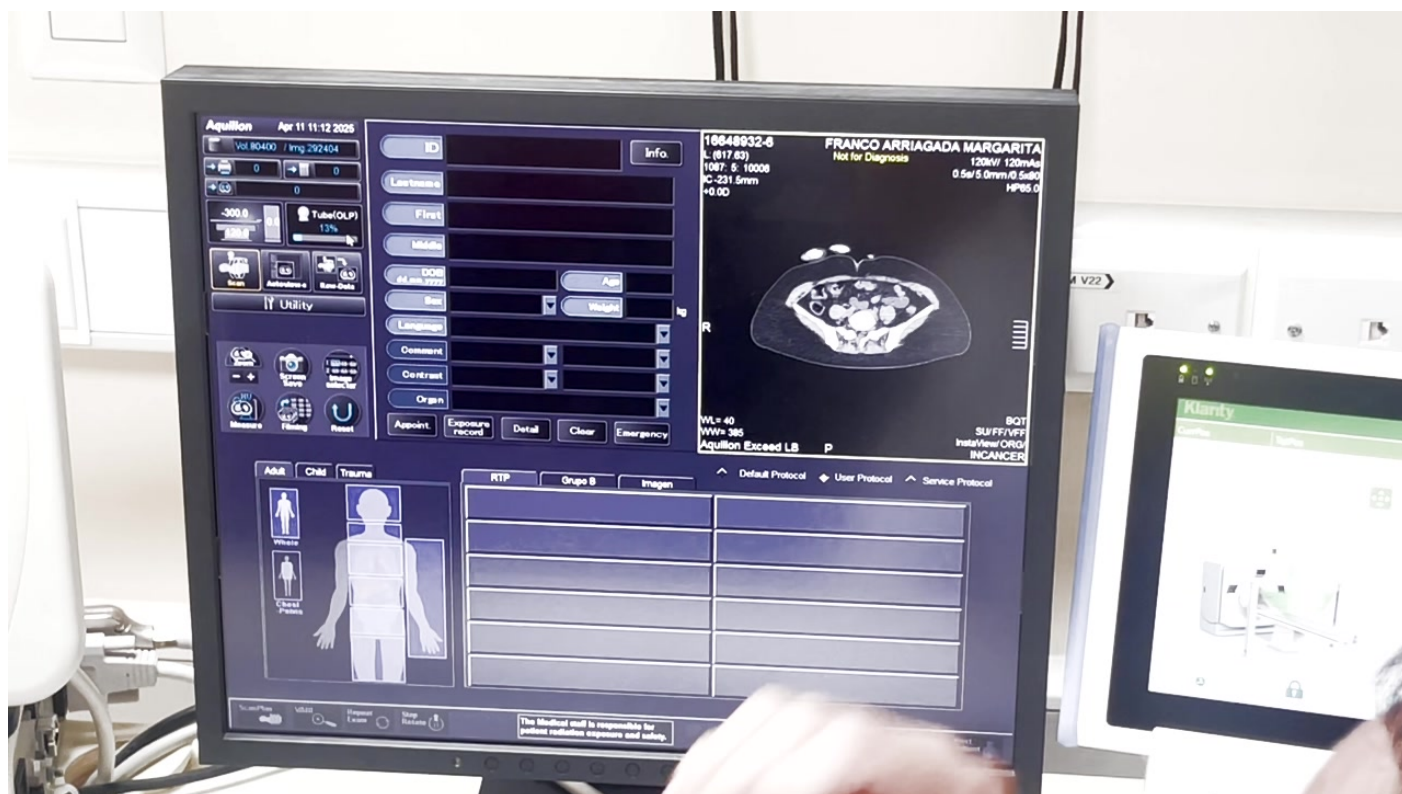
Al hacer clic en la fila de reconstrucción (marcada con 0) se pausará el proceso automático del equipo; se aconseja dejar que termine de forma fluida dado que es un proceso rápido.



PASO 5 · SEGURIDAD Y SISTEMA · 01:41

Monitorear la temperatura del tubo

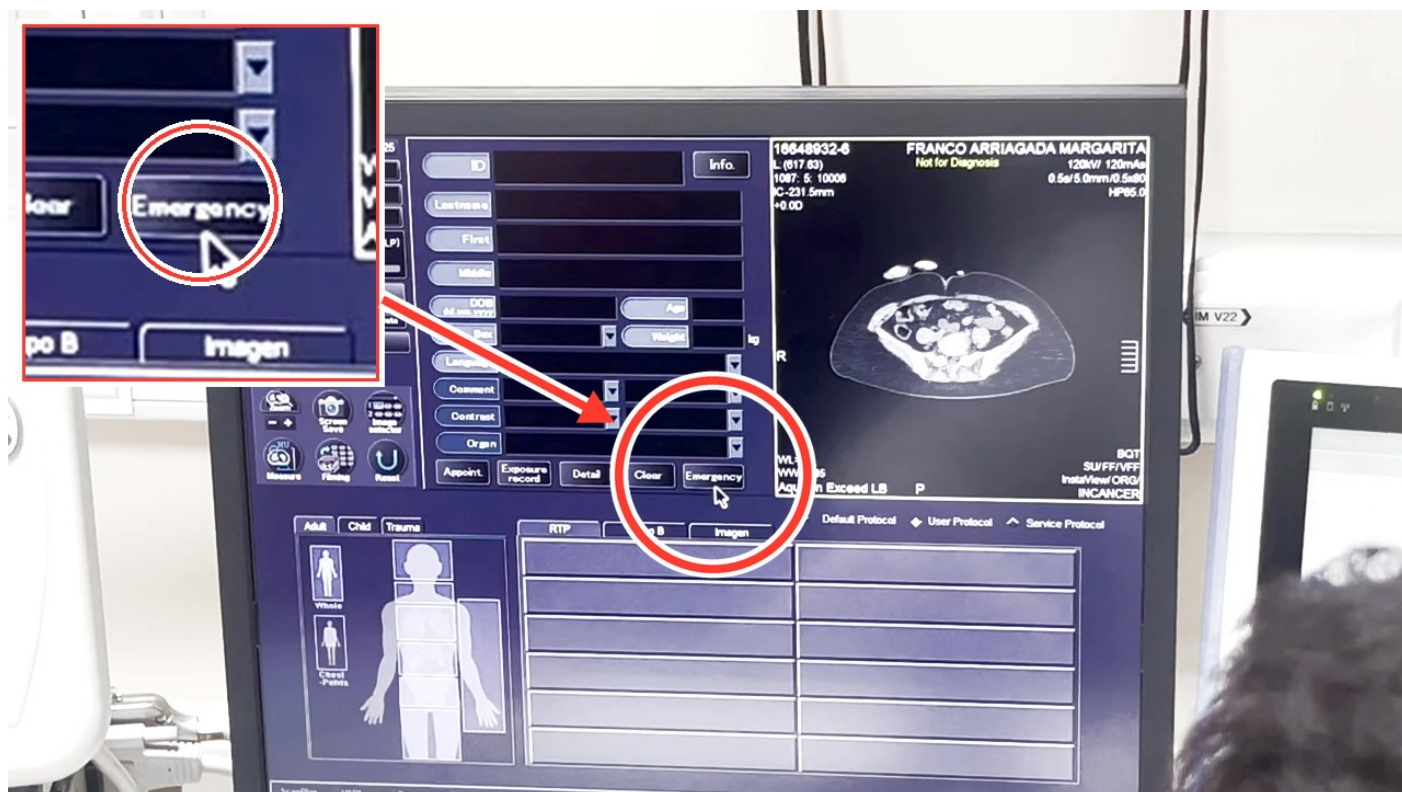
Se muestra el indicador 'Tube(OLP)' que indica el porcentaje termico del tubo (actualmente en 13% en pantalla); este valor ayuda a prever tiempos de espera entre adquisiciones exigentes.



PASO 6 · SEGURIDAD Y SISTEMA · 02:13

Advertencia de enfriamiento automático

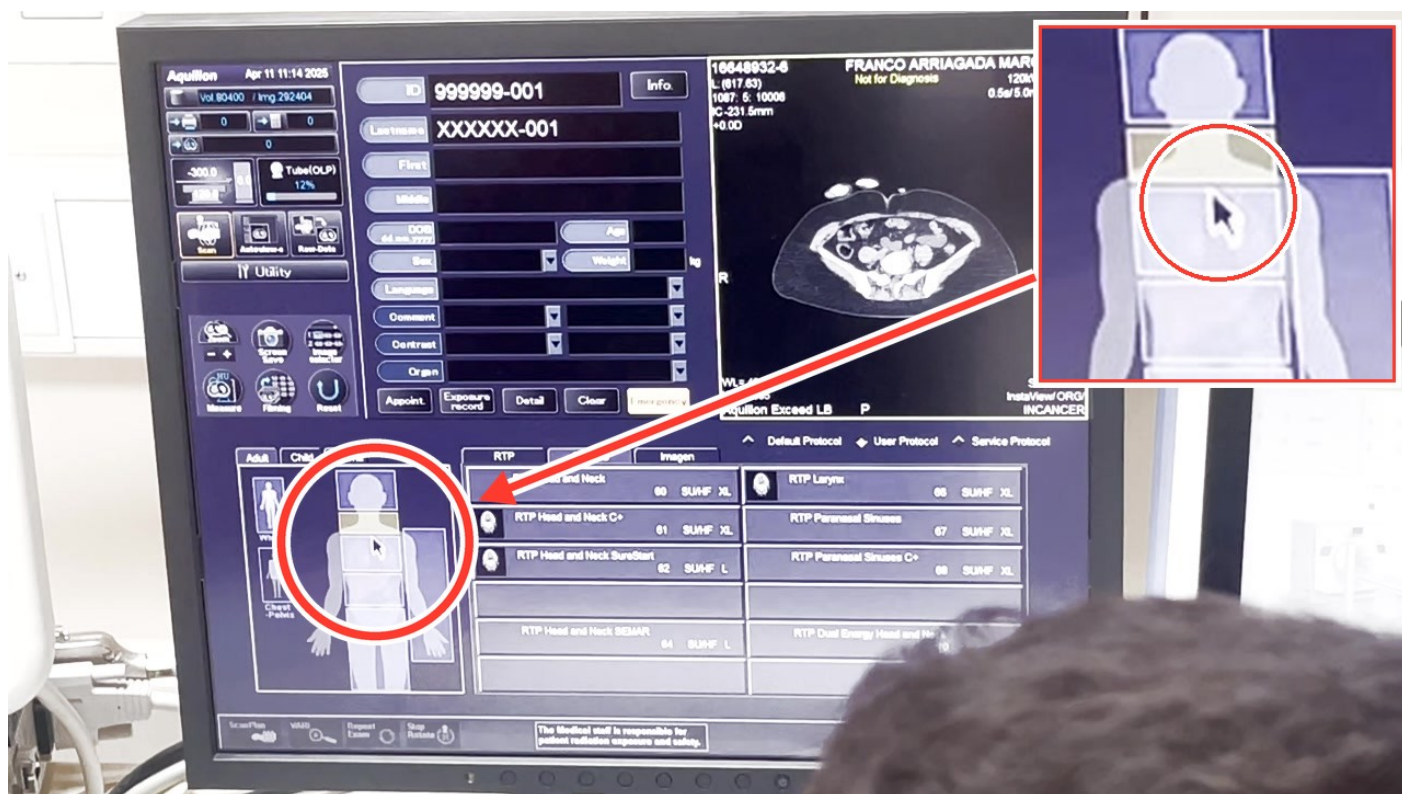
El equipo no cortará un examen en curso, pero avisará antes de iniciar la adquisición si requiere un tiempo específico en segundos para enfriar el tubo según la planificación.



PASO 7 · PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO · 03:45

Iniciar registro rapido de emergencia

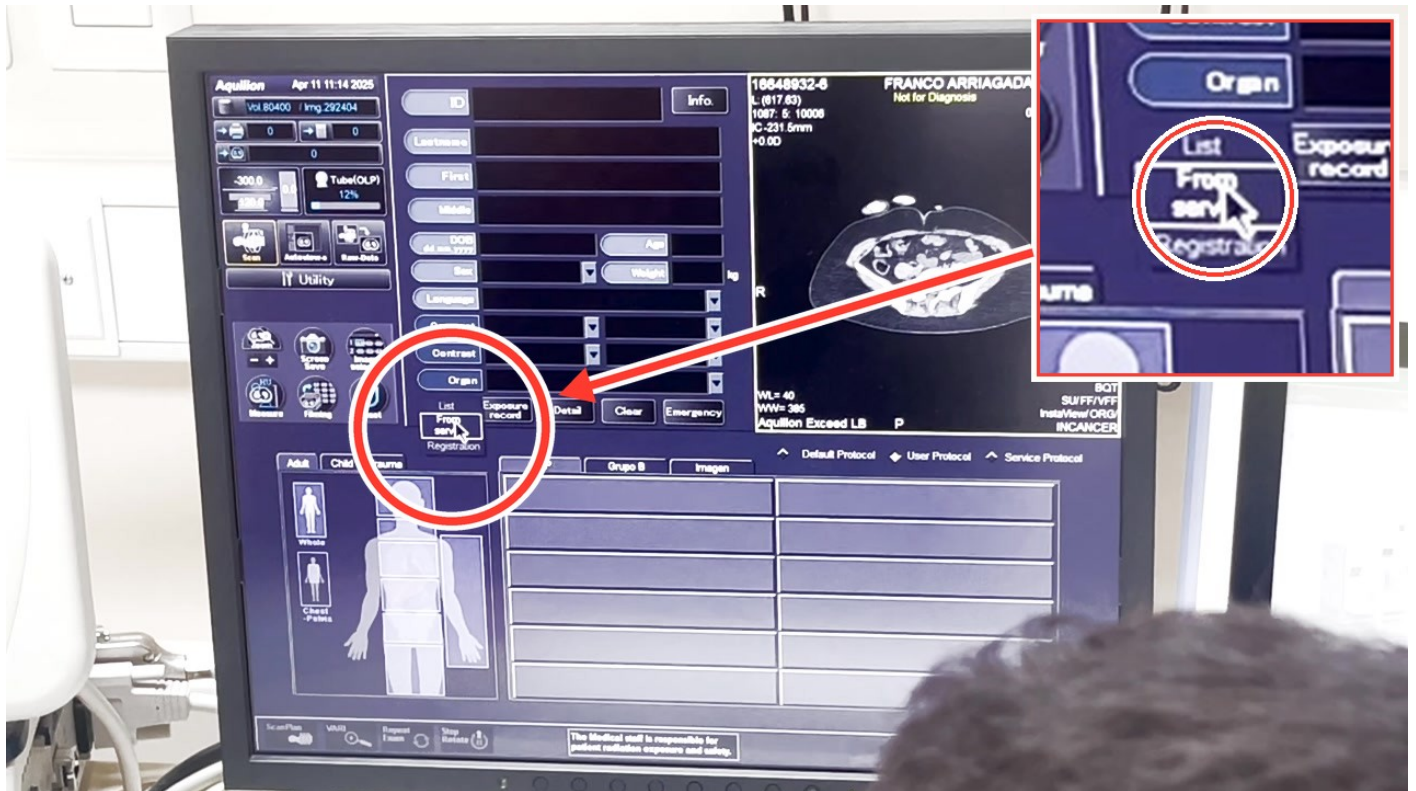
Al presionar el boton 'Emergency', el sistema genera datos de paciente anonimos para comenzar la adquisicion de forma inmediata en situaciones criticas.



PASO 8 · PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO · 03:52

Seleccionar protocolo por anatomia

Al seleccionar una zona del maniqui interactivo (como el cuello/hombros), se despliegan los protocolos correspondientes en la seccion derecha, por ejemplo, 'RTP Head and Neck'.



PASO 9 · PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO · 04:10

Cargar paciente desde el servidor

Para evitar la digitación manual, presionar el botón 'Appoint' para desplegar la opción 'From serv.' (en pantalla se lee 'From serv.') y así importar la lista de trabajo del hospital.

Transcripción del audio

- 00:00 La idea es no presionar acá, porque si presionas se va a abrir un menú que les va a mostrar como para gestionar, ya, este prioridad, pero el tema que si yo hago click, se detiene la transferencia.
- 00:10 Ah, ya. Entonces va a aparecer hold, después todos van a estar en hold, entonces yo les recomendaría no hagan click, a menos que vean algún problema.
- 00:17 Ya, pero se puede pasar, por ejemplo, que yo envíe la serie y no llegue y quiera revisar si es que se envió, de ahí sí.
- 00:25 Sí, claro, yo puedo presionar acá. Y acá dice todos completados, y este está activo.
- 00:30 Ya, y si uno está así como incompleto, ¿lo puedo de ahí reenviar?
- 00:35 Acá, restart. Y va a preguntar ¿a dónde? Y ahí uno le dice, no sé, al PACS, OK. Y ahí va a reiniciar el envío.
- 00:44 Voy a salir para que continúe. Esta es la fila de de impresión, no va, y esta es la fila de reconstrucción.
- 00:53 En caso de que se tomen, no sé, 1000 imágenes, y aquí va a aparecer 1000, 950, 900, empieza a bajar hasta llegar a cero. También se puede gestionar haciendo un click, pero si hacen un click, se detiene la reconstrucción.
- 01:05 Y el por qué se detiene es porque dicen, tú vas a gestionar esto, o sea, quiere decir reconstruye esta primero, esta después, pero en realidad esto es rápido, así que no debería ser el caso.
- 01:14 Perfecto, al momento de hacer una reconstrucción, por ejemplo, con a partir de un volumen, ya, un estándar, ya, y quiero eh hago una reconstrucción, dejo listo la reconstrucción en no sé qué, y yo quiero hacer el MPR de los tres al mismo tiempo, ¿acá se puede hacer o no? Sí, sí.
- 01:34 Eh, déjame terminar esto y y avanzamos. Eh, esto bueno, para mover la camilla.
- 01:40 Esta es la OLP del tubo, ¿cierto? Esto es para que tengan una referencia, porque puede llegar a 99, pero es para que sepan en qué está. Más que nada cuando lo van a apagar, cuando hay corte.
- 01:52 Si el equipo está con mucha temperatura el tubo, y sigue y otro y otro paciente, si hay algún problema así, de barridos largos, etc., el equipo le va a decir,
- 02:07 o sea, no les va a cortar un examen, va a decir: ¿sabes qué? Para este examen y esta planificación, le va a aparecer un mensaje acá: necesito, no sé, 128 segundos para que se enfríe el tubo porque si está en 80,
- 02:20 y tú estás planificando como 30%, entonces va a quedar en 70. Entonces les va a decir: necesito tantos segundos para que tú puedas, para que la carga calórica que le va a aplicar tenga espacio.
- 02:30 Algo así. Entonces va lo va a hacer automático. Por ejemplo, si ya un paciente es obeso mórbido, que está hecho para un obeso mórbido, eh tengo que hacer estudios básicos completos, un angio de cuerpo completo.
- 02:44 Ahí puede ser que, claro, tú planificas el examen del sin contraste, no sé, corte de prueba, bolus tracking, angio, venoso... Pero por ejemplo, al momento de que yo mando la angio, y después quiero tomar un venoso, y tengo un tiempo limitado, ¿el equipo me me va a cortar el examen o antes de empezar?
- 02:56 Va a arrojar ese mensaje. Pero antes de empezar la adquisición. Sí, para que no quedes corto y se te pase el tiempo. Antes de decir, para todo lo que tú quieres, tienes que esperar, no sé, 3 minutos.
- 03:10 Para que el tubo se enfríe, y tú puedas ejecutar todo como corresponde. Porque como ya tiene el doble escanograma, ya sabe la la densidad del paciente y cómo anda.
- 03:20 Y aparte, bueno, ah, pero acá son técnicas fijas, y el doble escanograma se saca la modulación para imagenología. Disculpen, pero la mente voy a hablar como si fuera para imagenología porque es lo del día a día, entonces le voy a hablar de modulación, ah no, de técnicas fijas, pero va a arrojar antes de.
- 03:39 Entonces, este menú Scan, y aparece la pantalla, ¿cierto? Acá ustedes pueden o en emergencia para poder ingresar al paciente, y acá en en el maniquí aparece por sección anatómica.
- 03:56 Para niños, bueno, tiene lo los protocolos de imagenología de ahí. ¿Cómo se cómo se ingresa la Worklist? Acá, de ir, ¿cierto? From server, Appointment, From server.
- 04:10 No creo que nos esté funcionando la Worklist. Pero cuando esté funcionando acá, reload y van a aparecer los, no sé, pues el paciente que quieran, doble click o marcar OK y se carga todo.
- 04:25 ¿No estaba conectado con el RIS? Sí, ingresamos un paciente, ¿no? Yo creo que no, no estoy seguro.